

Marcador AGHUX— Documento de Validação e Especificação de Negócio

- > **Padrão Oficial SETISD / HC-UFPE (HU Brasil) — Fase 0 (Alinhamento de Negócio)**
- > **Público-alvo:** Profissionais das áreas envolvidas e Equipe de TI.
- > **Objetivo:** Descrever o processo de trabalho em **linguagem pura de negócio** (sem jargões técnicos de programação ou banco de dados) para validação, alinhamento de expectativas e tomada de decisão antes de qualquer codificação.

1. Identificação do Projeto e Contexto Institucional

Campo	Descrição
Nome do Sistema	[Sistema Marcador de exame]
Área Solicitante / Cliente	[Gerência, Unidade ou Setor no HC-UFPE]
Instância Superior Competente	[Gerência à qual a área proponente esteja subordinada ou Superintendência]
Líder Técnico (SETISD)	[Analista de TI designado para prestar suporte técnico]
Objetivo Estratégico HU Brasil	[Vincular o projeto aos objetivos do HU Brasil]

2. O Problema que Queremos Resolver

- > **Objetivo:** O hospital enfrenta problema na organização e marcação dos exames, muitas vezes pacientes não conseguem marcar exame ou marcam errado. Quando chega na mão das marcadoras de exames elas tentam marcar o exame do paciente e não dá certo, além disso a planilha usada não demonstra separar nenhum paciente por grau de prioridade, então seria necessário alguma configuração que garantisse essa justiça.

* **A Dor Central:** *

Pacientes tem dificuldade ou não conseguem marcar exames direito.
Não há padronização de prioridade, é subjetivo a quem marca o exame na hora.

* **Por que isso não pode continuar (Impactos Reais):** *

- **Sobrecarga de Trabalho:** As chefias e equipes perdem horas redigindo dados e conferindo manualmente tarefas que poderiam ser automáticas.
- **Falta de Visibilidade:** A gestão não sabe em tempo real quem já entregou, quem está com pendências e onde estão os gargalos.
- **Risco Institucional e Legal:** Falta de histórico confiável para responder a auditorias, questionamentos de órgãos de controle ou conferências internas.

3. Como o Processo Funciona Hoje (A Rotina Atual)

> **Objetivo:** hoje o processo funciona através de um forms e planilhas. O paciente se cadastra no forms pra conseguir marcar um exame e as marcadoras de exame com base na planilha tentam marcar o exame no AGHU

* **Meios Utilizados Hoje:**

WhatsApp, planilhas, e AGHU

* **A Rotina Prática de Trabalho:**

1. **Início:** O paciente faz pedido de marcação de exame e a planilha é atualizada, com nome, código da solicitação e etc.
2. **Preenchimento:** As marcadoras de exames copiam e colam os dados necessários para fazer o agendamento de exame no AGHU, muitas vezes tendo recebido número de solicitação de exame errado, invalidando a marcação.
3. **Conferência:** - Não foi citado.
4. **Entrega e Arquivo:** - Ainda não citado, mas deve ter um processo de relatório e chega nas mãos dos superiores.

4. O Que a Nova Solução Deve Entregar (Resultado Esperado)

> **Objetivo:** Ter uma validação das informações para não ter problema de não conseguir marcar o exame. Haver uma view com os clientes, cores, e destacar informações cruciais para haver melhor condições para demonstrar mais dados para a escolha de quem vai ser marcado, com um grau de justiça.

* **A Proposta de Valor:** [Centralizar o processo em um ambiente web simples, onde os dados são validados e categorizados, só restando as marcadoras de exame copiarem e colarem os dados pro AGHU.*]

* **Ganhos Práticos Imediatos:**

- Fim da não marcação de exames compulsória.
- Alerta automático de erros ou inconsistências no momento da digitação.
- Assinatura eletrônica segura com registro de quem fez, quando aprovou e o que alterou.
- View de controle para todos poderem ver e consultar exames marcados, pendentes e já feitos.
- Backup das views para manter um histórico de registro a ser consultado.

5. Como Será o Trabalho no Novo Sistema (O Novo Fluxo)

> **Objetivo:** Explicar em linguagem direta como o usuário vai interagir com o sistema, resolvendo a dor do processo manual de ponta a ponta.

- * **1. Os dados já vêm prontos:** As marcadoras de exames já acessam a view com os dados de todos os pacientes que solicitaram exames.
- * **2. Preenchimento rápido com travas contra erros:** O responsável digita ou seleciona os paciente direto na tela. O sistema já usa travas de segurança, não permite o cadastro na planilhas com algumas das métricas citadas (ex: duplicidade de horários ou campos obrigatórios em branco, código de solicitação de exame errado), o próprio sistema avisa antes de salvar.
- * **3. Aprovação com um clique:** Quando o exame é marcado. O sistema registra automaticamente quem aprovou, data e hora, travando contra alterações indevidas. A chefia pode acompanhar essa view para gestão e conferência.
- * **4. Informação pronta e disponível:** A gestão acompanha em tempo real um painel mostrando quem já entregou e quem está pendente. A versão oficial homologada fica acessível para consulta imediata de quem tem direito, sem necessidade de procurar papéis ou cobrar por telefone.

6. Quem Participa do Processo (Atores: Como Faz Hoje vs. Como Fará no Sistema)

| Ator / Perfil no Hospital | O que faz HOJE (Rotina Manual) | O que passará a fazer no NOVO SISTEMA | O que NÃO poderá fazer |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ****Área Gestora do Processo**** *(Ex: Unidade de Pessoal, Farmácia Central, Regulação)* | Cobra prazos por telefone/e-mail, confere pilhas de papel ou junta dezenas de planilhas dispersas. | Habilita os períodos de trabalho, cadastra regras gerais, publica o resultado final e acompanha o painel geral de pendências em tempo real. | Não preenche dados rotineiros operacionais de setores individuais. |

| ****Profissional do Setor / Executante**** *(Quem realiza o atendimento ou rotina na ponta)* | . | Marca os exames com base na planilha não validada, além disso a justiça para marcar o exame é subjetiva e não há recursos há eles escolherem. | Não visualiza nem altera dados de setores que não sejam de sua alçada. |

| ****Chefia Imediata / Responsável pelo Setor**** *(Ex: Chefia de Unidade ou Setor)* | Confere folhas rubricadas à mão na mesa física, assina no papel e leva as pastas fisicamente. | Visualiza em uma tela única o trabalho da sua equipe, faz ajustes rápidos e aprova eletronicamente com um clique. | Não pode enviar lotes parciais ou com pendências em aberto. |

| ****Gestão / Coordenação Superior**** *(Ex: Chefia de Divisão ou Gerência)* | Não tem visão em tempo real das entregas; depende de relatórios manuais solicitados e demorados. | Acompanha indicadores gerais em tempo real (painel executivo com taxas de cumprimento de prazos e pendências). | Acesso estritamente para visualização gerencial (não edita registros operacionais). |

| ****Público / Usuário do Serviço**** *(Colaboradores do hospital, pacientes ou cidadãos)* | Precisa ligar, chamar no whatsapp, mandar e-mail ou ir presencialmente ao setor para obter uma informação ou comprovante. | Consulta com agilidade pelo portal, pesquisando por nome ou setor, com rapidez e transparência garantida. | Não tem acesso a dados restritos ou confidenciais. |

7. Regras de Negócio Inegociáveis (RNs)

* **RN-01 (Identificação Funcional Única):** O profissional é identificado exclusivamente pela sua matrícula funcional (SIAPE). Para preservar a privacidade e evitar riscos de vazamento, dados pessoais sensíveis desnecessários (como CPF) não são coletados nem expostos no sistema.

* **RN-02 (Prevenção de Duplicidade e Choques):** O sistema impede e bloqueia que a mesma pessoa seja alocada em dois setores, turnos ou atendimentos conflitantes no mesmo horário, eliminando de raiz o risco das planilhas paralelas manuais.

* **RN-03 (Preservação e Imutabilidade do Histórico):** O fechamento de um período ou a abertura de um novo ciclo nunca apaga, altera ou sobrescreve informações passadas. Registros homologados tornam-se imutáveis para garantir respaldo em auditorias e consultas futuras.

* **RN-04 (Homologação em Bloco / Entrega Completa):** A chefia de unidade só pode homologar e encaminhar para a gestão central o lote 100% completo de todos os seus setores subordinados. O sistema bloqueia entregas parciais ou com pendências não resolvidas.

* **RN-05 (Autenticação Institucional Obrigatória):** O acesso interno para preenchimento, conferência e aprovação exige login institucional com a conta de rede do hospital, vinculando a autoria e data/hora de cada ação realizada.

* **RN-06 (Transparência Ativa com Privacidade):** Na consulta pública ou da equipe, o sistema exibe apenas o nome completo, identificação funcional e a informação oficial aprovada, garantindo publicidade dos atos administrativos em conformidade com as diretrizes de privacidade.

8. Painel de Gestão e Indicadores Estratégicos (KPIs)

O sistema deve disponibilizar painel gerencial hierárquico (cada chefia enxerga o seu escopo) com os seguintes indicadores de negócio:

1. **Taxa de Cumprimento de Prazos:** Acompanhamento percentual e quantitativo em tempo real de quais setores e unidades já concluíram suas entregas dentro do calendário oficial, eliminando a necessidade de cobranças manuais por telefone.
2. **Mapa de Pendências e Atrasos:** Listagem imediata de unidades ou setores que ainda estão com preenchimento aberto, rascunho pendente ou com prazo vencido, permitindo atuação pontual da liderança.
3. **Detecção de Inconsistências:** Alerta visual automático para profissionais ativos que não possuem alocação ou registro no ciclo vigente, evitando esquecimentos ou desvios de planejamento.

9. Matriz de Pontos de Decisão (Gabinete / Gestão do Negócio)

> *Itens que dependem de confirmação dos gestores do hospital antes da conclusão:*

#	Ponto a Decidir	Impacto no Processo	Quem deve decidir?	Status / Definição
1	Data Limite Oficial	Até qual dia do período os setores devem fechar o preenchimento e assinar?	Define a regra do sistema para disparar alertas preventivos e travar edições intempestivas.	Gestão Central / Chefias  Em definição
2	Substituição de Chefia	Qual o critério para assinatura quando a chefia titular estiver de férias ou afastada?	Evita o travamento da homologação em bloco da unidade inteira por ausência de um único responsável.	Gestão da Área  Em definição
3	Retificação pós-Homologação	Qual é o rito formal para reabrir e corrigir dados já aprovados oficialmente?	Define se haverá solicitação formal de reabertura com justificativa gravada ou ajuste restrito à gestão central.	Gestão Central  Em definição

GUIA METODOLÓGICO: COMO ESTE DOCUMENTO SE INTERLIGA AOS DEMAIS ARQUIVOS DO PROJETO

> **Apresentação Executiva para a Chefia:**

> Esta seção explica a lógica de engenharia e governança adotada pelo SETISD para conectar as necessidades de negócio da ponta à construção do software.

A Linha do Tempo: A Separação entre "Fase de Negócio" e "Fase de Engenharia"

Em qualquer projeto de software hospitalar existem dois mundos que precisam se comunicar com perfeição:

- O Mundo do Negócio (Chefias, Áreas Solicitantes, Governança, Direção):** Não devem ser expostos a termos técnicos de TI (bancos de dados, endpoints, JSON, status HTTP, docker, etc.). Eles precisam discutir processos, dores reais, prazos, responsabilidades e regras.
- O Mundo da Engenharia (Desenvolvedores e Testes):** Precisam de tabelas relacionais, tipos de dados estritos, rotas de API seguras e casos de uso testáveis.

Este documento (`00-validacao-negocio.md`) funciona como a **Ponte Oficial** entre esses dois mundos:

```text

7

|        |  |                                                     |
|--------|--|-----------------------------------------------------|
| FASE 1 |  | 00-VALIDAÇÃO E FLUXO DE NEGÓCIO (ESTE ARQUIVO)      |
|        |  | Linguagem humana, fluxos e regras reais de negócio. |



| **\*\*Seção 9 (Matriz de Pontos de Decisão)\*\*** | Orienta os parâmetros de configuração e regras que alimentam as tarefas de implementação. | [SPEC.md](SPEC.md) **\*(Definições e Tarefas)\*** |

---

**### A Regra de Ouro do Processo no SETISD:**

1. **\*\*Início do Projeto (Fase de Negócio):\*\*** O profissional de TI preenche este documento junto com os responsáveis pela área de negócio em reuniões de alinhamento, validando o problema real, os fluxos práticos e as decisões pendentes.
2. **\*\*Desenvolvimento (Fase de Engenharia):\*\*** Com este documento aprovado pelas partes envolvidas, a equipe de desenvolvimento tem total clareza técnica para elaborar os artefatos de `01` a `06` e programar a solução com segurança e sem retrabalho.

**\*\*Resultado:\*\*** O cliente hospitalar participa ativamente sem ser sobrecarregado com termos técnicos, e a equipe de TI constrói exatamente o que o hospital precisa.